

## المونوتروبيزم وشبكة المراضة المشتركة: روابط مباشرة وغير مباشرة بحالات سلوكية ونفسية وعصبية نمائية

ملخص بحثي موثق.

### ملخص تنفيذي

**المونوتروبيزم (Monotropism)** (Murray, Lawson & Lesser, 2005) هو نظرية حول الانتباه التوحيدي تصيغ التوحد كاختلاف في تخصيص الموارد: العقل المونوتروبي يركز موارد المعالجة في عدد قليل من "أنفاق الانتباه" عالية الاستثارة، مما يترك موارد أقل للقنوات الطرفية. يوفر مقياس التقرير الذاتي لعام 2023 — **استبيان المونوتروبيزم (MQ)** — أول تحقق تجريبي، حيث سجل الأشخاص المصابون بالتوحد وADHD درجات أعلى بكثير من المجموعات الضابطة غير المصابة بالتوحد/ADHD [1][2][3]. ويجادل نموذج مراجع آخر وثيق الصلة، وهو نموذج غولدكنوبف (Goldknopf) لـ **التخصيص غير النمطي للموارد**، بأن هذا الانتباه الضيق والمكثف يمكن أن يربط بين الميزات الحسية والاجتماعية والتنفيذية والحركية للتوحد — مع التحذير من أنه "من المرجح أن يكون عاملاً لدى الأشخاص التوحيديين الذين يعانون من أعراض حسية قوية"، وليس السبب الوحيد [4].

بما أن المونوتروبيزم نظرية حول كيفية *إنفاق الموارد*، فمن المرجح أن يمتد تأثيرها إلى العديد من المجالات. ومع ذلك، فإن الصورة الصادقة تنقسم إلى ثلاث مستويات:

- **المستوى 1 — روابط مباشرة ومدعومة تجريبياً.** التداخل بين التوحد وADHD ("AuDHD") هو الأقوى: يظهر استبيان MQ أن الانتباه المونوتروبي مرتفع في كلتا الحالتين، مما يعيد صياغة "الانقسام المونوتروبي" (أنفاق متنافسة أو غير مستقرة) كنمط ظاهري انتباهي حقيقي وقابل للقياس [2][3][5]. التداخلات على مستوى الآلية — **الاستقبال الحشوي (interoception)** غير النمطي والخلل الوظيفي التنفيذي — مدعومة جيداً وتساعد في تفسير المشكلات اللاحقة المتعلقة بالأكل، والفوضى، والتجنب [6][7][8].
- **المستوى 2 — مراضة مشتركة غير مباشرة عبر آلية مشتركة.** يتداخل التوحد بشكل ملحوظ مع فقدان الشهية/الأكل المقيد والوسواس القهري (OCD).

في كل حالة، المراضة المشتركة حقيقية ومكررة، ولكن الجسر الأكثر دعماً بالأدلة هو آلية مشتركة (الاستقبال الحشوي؛ المعالجة المتوافقة مع الأنا مقابل المعارضة للأنا) بدلاً من المونوتروبيزم تحديداً [6][9][10].

- **المستوى 3 — استقرار محتمل أو مفاهيم متنازع عليها.** بعض الروابط في التصورات الشائعة — مثل "أكوام الفوضى" (doom piles) كفش في ثبات الأشياء المونوتروبي، أو رهاب الساح (agoraphobia) كنتيجة أولية للمونوتروبيزم، أو تجنب الطلب المرضي (PDA) كنمط متميز — تستند إلى أدلة ضعيفة أو متنازع عليها ويجب التعامل معها كفرضيات، وليس كحقائق مثبتة [11][12]. [13].

طوال هذا البحث، يتكرر موضوع واحد: العديد من السلوكيات التي تبدو كـ "اضطرابات" منفصلة يمكن قراءتها بشكل أفضل كـ **تكلفة معرفية لنظام انتباه ضيق يصطدم بعالم بوليتوبي (متعدد التركيز)** — ولكن بعض هذه القراءات فقط تم اختبارها بشكل مباشر.

## 1. الأسس: ما هو المونوتروبيزم، ومدى صلابته العلمية

يقترح المونوتروبيزم أن العقول تختلف في كيفية توزيع موارد الانتباه. العقل **البوليتوبي (polytropic)** يبقي العديد من قنوات الاهتمام نشطة في وقت واحد (واسعة، ضحلة، سهلة التنقل)؛ أما العقل **المونوتروبي (monotropic)** فيوجه الموارد إلى عدد قليل من "أنفاق الانتباه" المثارة بشدة (ضيقة، عميقة، يصعب التنقل منها) [1][3]. قدم المؤسسون — ديناه ماري، وين لوسون وميك ليسر — الفكرة لأول مرة في مؤتمرات دورهام للتوحد منذ عام 1992 وصاغوها رسمياً في عام 2005، مجادلين بأنها تشرح سمات التوحد (الاهتمامات الخاصة، الحاجة إلى التماثل، الضيق عند الانتقالات، التركيز على التفاصيل) بشكل أفضل من النماذج القائمة على العجز فقط [1][14].

لقد تحولت مكانته العلمية في السنوات القليلة الماضية:

- **هو قابل للقياس تجريبياً.** استبيان (Garau et al., 2023) MQ هو أداة تقرير ذاتي مكونة من 47 بنداً تم اختبارها على 1,110 مشاركاً (756 توحد، 354 غير توحد). سجل المشاركون المصابون بالتوحد وADHD درجات أعلى بكثير من المجموعات الضابطة [2][3].
- **لديه قريب ميكانيكي مراجع من قبل الأقران.** نموذج غولدكنوبف "تخصيص الموارد غير النمطي" (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) يضع الحدس في قالب إجرائي: في التوحد، تكون موارد الانتباه **ضيقة** (إلى مناطق/ أنماط ومراحل معالجة أقل/أصغر، وأحياناً بشكل أكثر كثافة) و/أو **مخفضة** في القدرة الإجمالية — وهو إطار يربط صراحة بين اللغة، والادراك الاجتماعي، والنمطية الحسية/الانتباهية، والاختلافات التنفيذية/الحركية [4].
- **هو يأتي جنباً إلى جنب، وليس بدلاً من، النظريات المعرفية الأخرى (نظرية العقل؛ التماسك المركزي الضعيف / الأسلوب المركز على التفاصيل (Happé & )**

(Frith, 2006); (الخلل الوظيفي التنفيذي) [4][15].

- لا يزال نموذجاً وليس علامة بيولوجية. يوضح غولدكنوبف أنه عامل واحد من بين عدة عوامل، ومن "المرجح" أن يكون بارزاً لدى الأشخاص التوحديين الذين يعانون من أعراض حسية قوية [4]. وبالمثل، تصيغ ماري وزملاؤها المونتروبيزم كعدسة موحدة، وليس كسببات كاملة [1][14].

**النتيجة بالنسبة لبقية هذا الملخص:** المونتروبيزم فكرة تنظيمية موثوقة ومدعومة بشكل متزايد، ولكن نطاقها التفسيري لكل مراضة مشتركة يجب أن يُناقش حالة بحالة — لا يفترض كقاعدة.

## 2. المستوى 1 — روابط مباشرة: العنقود النمائي العصبي

### 2.1 AuDHD و"الانقسام المونتروبي" (أقوى رابط مباشر)

يحدث التداخل بين التوحد وADHD بمعدل أكبر بكثير مما يتوقعه الصدفة: يتواجد ADHD في حوالي 30-80% من الأشخاص التوحديين، والتوحد في حوالي 20-50% من المصابين بـ [5] ADHD؛ تشير مراجعة شاملة إلى أن معدلات أعراض ASD في عينات ADHD تبلغ حوالي 21% [16]؛ وجدت إحدى الدراسات الكبيرة من Medicaid أن 27% من البالغين التوحديين الذين لا يعانون من إعاقة ذهنية لديهم تشخيص ADHD مصاحب — أي حوالي 10 أضعاف المعدل العام [17]. التداخل جيني بشكل كبير (~50-72%) [18].

يساعد المونتروبيزم في حل لغز قديم: إذا كان التوحد "تركيزاً فائقاً" وكان ADHD "تشتتاً في الانتباه"، فلماذا يتداخلان؟ يجب استبيان MQ على ذلك تجريبياً — **الأشخاص المصابون بـ ADHD، وخاصة المصابون بـ AuDHD، هم أيضاً مونتروبيون للغاية** [2][3]. التركيز الفائق في ADHD (Grotewiel et al., 2022) يتطابق مفاهيمياً مع النفق المونتروبي [19]. وبناءً على ذلك، تعيد صياغة "الانقسام المونتروبي" الـ AuDHD ليس كمتناقضات بل ك**نظام غير مستقر من أنفاق الانتباه المتنافسة أو سريعة التحول**: يطلب الدماغ تركيزاً مونتروبياً عميقاً ولكنه لا يستطيع تثبيت النفق، مما ينتج عنه التذبذب المألوف في AuDHD بين الاندماج الشديد، والاحتراق السريع، ونقص التحفيز المزمن [19][20].

**تنبيه:** آلية "الأنفاق المتنافسة المتعددة" هي منطقية وتتسق مع بيانات MQ ولكن لم يتم اختبارها بعد كديناميكية حركية؛ لذا يجب قراءتها كفرضية قوية.

### 2.2 الاحتراق التوحدي واضطراب النفق

الاحتراق التوحدي — الإرهاق المزمن، فقدان المهارات، وانخفاض التحمل — يرتبط بشكل متزايد بالتكلفة التراكمية للتبديل المستمر في الأنفاق، والتمويه (masking)، والطلبات التي تتجاوز القدرة، مع عدم كفاية وقت التعافي/التدفق [20][21]. هذه منطقة يكون فيها المونتروبيزم قوياً من الناحية الاستدلالية (كل انتقال قسري هو تمزق للنفق)، رغم أن أدبيات الاحتراق نفسها لا تزال في طور النضج ومسار المونتروبيزم → الاحتراق هو سريري/تجربي في الغالب وليس مؤسساً تجريبياً [20].

### 2.3 تجنب الطلب و PDA (مفهوم متنازع عليه)

الطلب — "استعد"، "املاً هذه الاستمارة" — يمكن تجربته كاقترام عنيف لحالة التدفق (flow). هذا هو التفسير المونتروبي الحدسي لـ **تجنب الطلب**. المفهومات الأكثر تحديداً لـ **تجنب الطلب المرضي (PDA)**، التي صاغتها إليزابيث نيوسون في الثمانينيات ويُعاد صياغتها الآن كـ "دافع غريزي للاستقلالية"، تصف حاجة مدفوعة بالقلق للسيطرة وتجنب الطلبات العادية [11][22].

يجب الفصل بين أمرين:

- **سلوك تجنب الطلب حقيقي وشائع** في التوحد، وتفسير "تمزق النفق" المونتروبي هو قصة ميكانيكية معقولة للذعر والمقاومة التي ينتجها.
- **PDA كنمط متميز أو نوع فرعي غير مثبت**. تذكر الجمعية الوطنية للتوحد في المملكة المتحدة أنه "لا توجد أبحاث وجدت أدلة قوية على [PDA] كنمط متميز" [11]؛ وقد تعرضت دراسة نيوسون التأسيسية للنقد بسبب **التفكير الدائري والتفسير المفرط** (المجموعات حددها الباحثون ثم "درستها") [12][13]؛ وتشير المراجعات إلى مشاكل مستمرة في التعريف، وصلاحيّة المفهوم، والقياس [23]. مراجعة لعام 2023 جاء عنوانها بشكل صريح: "تجنب الطلب المرضي: الحالة الراهنة للأبحاث والنقاش النقدي" [13].

لذا فإن صياغة النص الأصلي صحيحة جزئياً: التجربة (الطلب يحطم النفق) مشروحة جيداً بالمونتروبيزم؛ أما الكيان التشخيصي (PDA) فهو متنازع عليه ولا ينبغي تقديمه كأمر محسوم.

---

## 3. المستوى 2 — مراضة مشتركة غير مباشرة عبر آلية مشتركة

### 3.1 فقدان الشهية والأكل المقيد

التداخل بين التوحد وفقدان الشهية قوي ومتبادل: حوالي 20-30% من مرضى اضطرابات الأكل يظهرون سمات توحدية ذات دلالة سريرية، مع أعلى المعدلات في فقدان الشهية العصبي و[24][6] ARFID؛ وعلى العكس، البالغون التوحيديون لديهم معدلات مرتفعة من اضطرابات الأكل. والأهم من ذلك، تلاحظ السمات التوحدية قبل ظهور اضطرابات الأكل، لذا فإن التداخل ليس مجرد تأثير للجوع [6].

الجسر الميكانيكي الأكثر دعماً بالأدلة هو **الاستقبال الحشوي (interoception)** — إدراك الإشارات الجسدية الداخلية (ضربات القلب، الشبع). الاستقبال الحشوي غير النمطي متورط في مسببات كلا التوحد واضطرابات الأكل و"قد يكون، جزئياً، مسؤولاً" عن مراضتهما المشتركة [6]. هذا الاختلاف في الاستقبال الحشوي يكمن أيضاً في أساس **أليكسيثيميا (alexithymia)** (صعوبة تحديد/تعبير عن العواطف)، الموجودة لدى ~50% من التوحيديين وهي بدورها مرتبطة باعتلالات الأكل [7][8].

**أين يتناسب المونتروبيزم (وأين لا يتناسب):** من المعقول القول بأن الشخص المونتروبي الغارق في نفق قد يغفل عن إشارات الجوع — ولكن الادعاء المحدد في النص الأصلي بأن "المونتروبيزم يقلل من الاستقبال الحشوي" يبالغ في السلسلة السببية. العلاقة المثبتة هي **توحد → استقبال حشوي/أليكسيثيميا غير نمطية → عرضة لاضطرابات الأكل**؛ المونتروبيزم ميزة موازية للتوحد، وليس السبب المثبت للاختلاف في الاستقبال الحشوي [6][7]. كما يمكن أن يصبح تتبع الطعام/السعرات الحرارية نفقاً في حد ذاته، ولكن هذا أمر محتمل ميكانيكياً وليس مختبراً.

### 3.2 الوسواس القهري مقابل التركيز الفائق: تمييز حقيقي

يتداخل التوحد والوسواس القهري بشكل كبير: حوالي 17% من التوحدين يستوفون معايير الوسواس القهري، مقابل ~1-2% في السكان العامين [9]. ورغم التشابه السطحي (سلوكيات تكرارية، صلابة)، فإن **المحرك العاطفي يختلف** وهذا مثبت سريرياً:

- الاهتمامات والروتينات **التوحيدية** تكون عادة **متوافقة مع الأنا (ego-syntonic)** — ممتعة، مهدئة، مدفوعة بالاهتمام، وغالباً ما تكون تنظيمية.
- وسواس الـ **OCD** يكون **معارضاً للأنا (ego-dystonic)** — غير مرغوب فيه، مدفوع بالقلق، ويتم تنفيذه لتحقيق نتائج مخيفة [9][10].

لذلك، فإن تمييز النص الأصلي صحيح ومدعوم بالأدلة، ويؤكد المشاركين التوحديون أنفسهم: في دراسة نوعية، ذكروا أن السلوكيات التكرارية هي "جزء من هويتهم"، بينما أعراض الوسواس القهري "تعارض مع كيف يرون أنفسهم" [10]. وتصف الدراسة ذاتها التداخل بدقة: **"التوحد هو الساحة والوسواس القهري هو الأسد"** — حيث يمكن لأعراض OCD أن "تختطف" الاهتمامات التوحيدية، مما يزيد من شدتها وضيقها [10]. يضيف المونتروبيزم سياقاً (يمكن للنفق أن يتم اختطافه بمحتوى وسواسي) ولكن التمييز يستند إلى محور التوافق/المعارضة مع الأنا، وليس على المونتروبيزم بحد ذاته.

### 3.3 القلق والاضطرابات العاطفية (الركيزة تحت "رهاب الساح")

القلق هو أحد أكثر الأمراض المشتركة شيوعاً في التوحد (إحدى المراجعات الثانوية تذكر وجود  $\leq 1$  مراضة نفسية في ~86% من التوحدين) [25]. هناك نقطتان ميكانيكيتان مهمتان للعنقود السلوكي أدناه: (1) **فرط الاستجابة الحسية** والقلق مرتبطان، ومن خلال التكيف السياقي ينتجان **تجنباً سلوكياً لأماكن عامة** (مطاعم، محلات، حفلات) [26]؛ (2) التداخل الشائع مع الأليكسيثيميا/صعوبة الاستقبال الحشوي يعني أن الحالات العاطفية غالباً ما يتم تصنيفها بشكل خاطئ، مما يغذي القلق العام [7].

## 4. المستوى 3 — العنقود السلوكي/الوظيفي: الفوضى، الاكتناز، التجنب، الانسحاب الاجتماعي

### 4.1 الفوضى، "أكوام الفوضى" (doom piles)، والخلل الوظيفي التنفيذي

الظاهرة مدعومة جيداً: الأشخاص المصابون بالتوحد وADHD يظهرون معدلات عالية من عدم التنظيم والفوضى، والمسار الأكثر دعماً بالأدلة هو **الخلل الوظيفي التنفيذي** — عجز في التصنيف، واتخاذ القرار، والتخطيط، والذاكرة العاملة [8][27]. أعراض الاكتناز مرتفعة في كل من ADHD (مع "رابط خاص بنقص الانتباه" [8]) والتوحد [8]؛ وفي التوحد تحديداً، تظهر الأعمال النوعية أن صعوبة التخلص من الأشياء مرتبطة **بالارتباطات العاطفية والمعنى**، وليس مجرد قيمة الشيء [28].

**تنبيه بشأن النص الأصلي:** الادعاء المحدد بأن الفوضى تستمر بسبب "عجز في ثبات الأشياء" (**object-permanence deficit**) لدى التوحديين ("بعيد عن العين، بعيد عن العقل") غير مدعوم بأدلة مراجعة من قبل الأقران مما استطعت العثور عليه. ثبات الأشياء يكون عادة سليماً أو متفوقاً في التوحد؛ وتجربة "بعيد عن العين، بعيد عن العقل" تُقرأ بشكل أفضل كأثر للذاكرة العاملة/تخصيص الانتباه (العقل المونتروبي لا يعيد التوجه إلى العناصر المخزنة) وليس كفشل في إدراك ثبات الأشياء. الآلية المثبتة للفوضى تظل **الخلل الوظيفي التنفيذي بالإضافة إلى الارتباط بالاهتمامات**، وهو ما يتداخل مع السكان المونتروبيين/AuDHD ولكن ليس "مونروبياً" بشكل حصري [4][8][28].

### 4.2 سلوك طيف الاكتناز

اضطراب الاكتناز يصيب ~1.5-6% من السكان العامين ولكنه مرتفع في التوحد [29]. لدى البالغين التوحديين، تظهر صعوبة الاكتناز مرتبطة بـ **صعوبات معرفية (تنفيذية) وارتباطات قوية بالمعنى والاهتمام** — الأشياء هي عقد في شبكة من الأفكار ومنفعة مستقبلية، لذا فإن التخلص منها يشعرهم بالخسارة [28]. وهذا يتسق مع أسلوب مونتروبي (معالجة عميقة للأشياء) ولكن، مرة أخرى، المحرك المثبت هو الوظائف التنفيذية/الارتباط، وهو مشترك عبر الحالات النمائية العصبية [8].

### 4.3 رهاب السباح و"تحديد المساحة الآمنة" (يحتاج تصحيح)

- يصيغ النص الأصلي حبس الذات في المنزل كأثر مباشر للمونتروبيزم. البيانات أكثر دقة: رهاب السباح مرتفع في التوحد — ~23-25% من البالغين التوحديين (بدون إعاقة ذهنية) مقابل ~1.3% في السكان العامين — **لكنه أقل شيوعاً من الرهاب الاجتماعي أو القلق العام (GAD)**، ويتركز التأثير في أولئك الذين ليس لديهم إعاقة ذهنية [25].
- المحرك الأكثر دعماً بالأدلة هو **فرط الاستجابة الحسية + القلق الاجتماعي**، مع تجنب سلوكي للأماكن المجهدة حسيّاً — أي أن سلوك "المساحة الآمنة" حقيقي ولكنه **ثانوي للقلق الحسي/الاجتماعي**، وليس ظاهرة مونتروبية أولية [25][26].



لذا: المونتروبيزم يساعد في تفسير لماذا يبدو العالم الخارجي مشتتاً (غير متوقع، بوليتوبي، يمزق الأنفاق)، ولكن تصنيف الحبس الناتج كـ "رهاب ساح" خاص بالمونتروبيزم يبالغ في الرابط. إنه تجنب مدفوع بالقلقات الحسية التي تتداخل مع التجربة المونتروبية.

#### 4.4 الانسحاب الاجتماعي، "تفريغ المعلومات" (info-dumping)، ومشكلة التعاطف المزدوج

التفاعل الاجتماعي هو بطبيعته بوليتوبي — يتطلب تتبعاً متزامناً للوجوه، والنبرة، والتسلسل الهرمي، والتوقيت، والقواعد غير المكتوبة — لذا فهو مكلف بشكل غير متناسب للنظام المونتروبي، وهي نقطة تتسق مع نموذج الموارد لغولدكنوبف [4]. حدس النص الأصلي سليم.

لكن الإطارات الأكثر حدة ودعمًا تجريبيًا للانهيال في التواصل هي مشكلة التعاطف المزدوج (Double Empathy Problem) (Milton, 2012; 2017): الصعوبة هي ثنائية الاتجاه وعلاقية — انفصام في التبادل بين فاعلين اجتماعيين مختلفين في التوجه — وليست عجزاً في التعاطف من جانب الشخص التوحيدي وحده [30]. تظهر الأعمال التجريبية الآن أن المراقبين غير التوحيدين يكتشفون ويظهرون أيضاً مشكلة التعاطف المزدوج في التفاعلات المختلطة [31]. "تفريغ المعلومات" يتناسب طبيعياً مع هذا: فهو تواصل يبحث عن العمق من نظام مونتروبي، ويفشل عندما لا يستطيع الشريك مطابقة هذا العمق — وهو تعارض في أساليب المعالجة، وليس نقصاً في التعاطف [30][31].

**فجوة للتنبيه:** أدبيات DEP لا تزال تستبعد إلى حد كبير الأطفال التوحيدين، الأشخاص غير الناطقين، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، لذا فإن التعميم محدود [32].

#### 5. الحدود: أين يذهب التفسير المونتروبي بعيداً جداً

| الادعاء في التصورات الشائعة                     | الحالة العلمية                | التفسير الأفضل                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المونتروبيزم يسبب سمات التوحد                   | مدعوم جزئياً (MQ; Goldknopf)  | عامل تنظيمي واحد من عدة عوامل؛ أبرز ما يكون في التوحد ذي الأعراض الحسية القوية [1][4]                                           |
| AuDHD = "انقسام مونتروبي" (أنفاق متنافسة)       | قوي + قابل للقياس مباشرة (MQ) | نمط ظاهري انتباهي حقيقي؛ الآلية الديناميكية هي فرضية                                                                            |
| PDA هو نمط متميز من التوحد                      | متنازع عليه                   | تجنب الطلب حقيقي؛ PDA ككيان يفقر لصلاحية المفهوم [11][12][13]                                                                   |
| المونتروبيزم يقلل الاستقبال الحشوي → فقدان شهية | غير مباشر                     | الجسر هو التوحد → استقبال حشوي/أليكسيثيميا غير نمطية → عرضة لاضطرابات الأكل؛ المونتروبيزم ميزة موازية، وليس السبب المثبت [6][7] |

| الادعاء في التصورات الشائعة                   | الحالة العلمية        | التفسير الأفضل                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| فوضى بسبب "عجز في ثبات الأشياء"               | غير مدعوم             | خلل وظيفي تنفيذي + ارتباط بالاهتمام؛ لا يوجد عجز في ثبات الأشياء المدرك [4][8][28]     |
| رهاب الساح كنتيجة أولية للمونوتروبيزم         | مبالغ فيه             | ثانوي لفرط الاستجابة الحسية + القلق الاجتماعي؛ أقل شيوعاً من GAD/رهاب اجتماعي [25][26] |
| OCD مقابل "هواجس" مونوتروبية تختلف في العاطفة | مدعوم جيداً           | متوافق مع الأنا (توحد) مقابل معارض للأنا (OCD)؛ OCD يمكن أن "يختطف" الأنفاق [9][10]    |
| مشكلة التعاطف المزدوج تفسر الانهيار الاجتماعي | مدعوم (مع وجود فجوات) | سوء تفاهم ثنائي الاتجاه؛ العينات تميل للبالغين الناطقين بدون إعاقه ذهنية [30][31][32]  |

## 6. أسئلة مفتوحة

1. **الاختبار الديناميكي للنفق.** استبيان MQ هو مقياس سمات. هل "الانقسام المونوتروبي" (الأنفاق المتنافسة في AuDHD) قابل للملاحظة في الوقت الفعلي عبر EEG أو اختبارات الانتباه؟ غير مختبر إلى حد كبير.
2. **السهم السببي للاستقبال الحشوي.** هل توزيع الموارد المونوتروبي ينتج الاستقبال الحشوي غير النمطي، أم يتشارك في سبب مشترك في الأعلى؟ الأدلة الحالية لا تفصل بينهما [6][7].
3. **قرار PDA.** هل سيتقارب البحث حول تجنب الطلب في مفهوم موحد وقابل للقياس، أم سيظل فئة سريرية متنازعة عليها؟ [11][13]
4. **ميكانيكية الفوضى.** هل تجربة "بعيد عن العين، بعيد عن العقل" هي أثر للذاكرة العاملة/تخصيص الانتباه (محتمل) أو شيء آخر؟ لم يتم العثور على دراسة مخصصة.
5. **تعميم DEP.** كيف تعمل مشكلة التعاطف المزدوج بالنسبة للأشخاص التوحديين غير الناطقين، الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؟ [32]
6. **الاحتراق.** ما هي المساهمة المحددة والقابلة للاختبار لتمزق النفق المونوتروبي في الاحتراق التوحدي مقابل القناع، الصدمات والطلبات المفرطة؟ [20]

## المصادر

Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism [1] and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139–156.  
عبر <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>



<https://monotropism.org/murray-lesser-lawson> [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint) تعليق/ملخص:

<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; امرأة: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> — ملخص نتائج MQ [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) (47 بنداً؛ N=1,110؛ سجل التوحديين وADHD درجات أعلى بكثير من المجموعات الضابطة): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.

— <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub مراجعة تداخل ADHD والتوحد (ADHD في ~30-80% من ASD؛ ASD في ~20-50% من ADHD؛ تذكر مراجعة 2019 Hollingdale؛ Lau-Zhu 2019): <https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsy.2025.1573263) — ~50% لديهم أليكسيثيميا، بوساطة عجز الاستقبال الحشوي.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.

[8] — <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> "الرابط الخاص بنقص الانتباه" هو العنوان الفرعي للورقة. انظر أيضاً معهد Drake حول ADHD/الخلل الوظيفي التنفيذي: <https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — ملخص مراجعة منهجية: ~17% من التوحديين يستوفون معايير OCD مقابل ~1-2% في السكان العامين؛ التمييز بين متوافق مع الأنا مقابل معارض للأنا: <https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of

co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitative). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11]

[PDA] — National Autistic Society — تجنب الطلب ("لم تجد الأبحاث أدلة قوية على كنمط متميز"): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education

Green et al. 2018; O'Nions) — نقد تفكير نيوسون الدائري (2024). طرق دراسة PDA — (& Eaton 2020

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (مستشهد بها في دراسة مقارنة 2024 Frontiers)

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (مستشهد بها في Psych Scene Hub و Autistica)

<https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27% ذهنية لديهم تشخيص ADHD مصاحب — حوالي 10 أضعاف المعدل العام: <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations ملخص: <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-adhd>

Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" [19] (AuDHD) كأفانق متنافسة؛ يشير إلى 2022 Grotewiel et al. حول التركيز الفائق في ADHD): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — المونوتروبيزم، الشباب والاحتراق التوحدي: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — استعادة الراحة: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — ما هو المونوتروبيزم؟ (حالات التدفق؛ يشير إلى 2024 Heasman et al. "نظرية التدفق التوحدي"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — ما هو PDA؟ (نيوسون، الثمانينيات؛ إعادة الصياغة إلى "دافع غريزي للاستقلالية"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Westwood, Mandy & (يستشهد أيضاً بـ) *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791. (Tchanturia 2017; Huke et al. 2013)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — رهاب الساح في التوحد ~23-25% (بدون إعاقة ذهنية) مقابل ~1.3% عام; أقل شيوعاً من الفوبيا الاجتماعية أو GAD (مصدر ثانوي، يعتمد على Helles et al. 2020 و Lugnegård et al. 2012):

<https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* PMC2980623. — التكيف السياقي وتجنب المواقع العامة.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — التوحد والاكتناز (خلل وظيفي تنفيذي، اتخاذ قرار): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (qualitative). *Autism*. PMC8264636.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887; Milton (2017) <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351.

[32] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> ويكيبيديا — مشكلة التعاطف المزدوج (اعتراف بالفجوات البحثية: الأطفال، غير الناطقين، ذوي الإعاقة الذهنية): [https://en.wikipedia.org/wiki/Double\\_empathy\\_problem](https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem)

---

ملاحظة حول مستويات الأدلة: المستوى 1 = قياس مباشر ومكرر (MQ); معدلات  
(AuDHD); المستوى 2 = مراضة مشتركة مكررة مع آلية مشتركة مثبتة; المستوى 3 =  
استقراء محتمل، مصدر واحد، أو مفهوم متنازع عليه. انظر §5.